Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Lajeado

Rua Paulo Frederico Schumacher, 77 - Bairro: Moinhos - CEP: 95900780 - Fone: (51) 3710-1500 - Email: frlajeado2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005447-36.2021.8.21.0017/RS

AUTOR: GECICA SAUTHIER PENZ

RÉU: UNIMED VALE DO TAQUARI E RIO PARDO

SENTENÇA

Vistos.

GECICA SAUTHIER PENZ ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para fornecimento de medicamento em face de **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.,** todos qualificados. Narrou ser a autora portadora de Trombofilia e necessita fazer uso do fármaco ENOXAPARINA, durante o período gestacional, havendo indicação de que o não uso do medicamento poderá causar complicações obstétricas variadas. Referiu que administrativamente o fornecimento do medicamento foi recusado pela requerida, o que defende ser injusto e recorre ao Poder Judiciário. Postulou, em tutela de urgência, que o Requerido forneça o medicamento Enoxaparina sódica 40mg para aplicação 1x ao dia, durante o período gestacional e 06 semanas após o parto. Ao final, postulou a procedência da ação, confirmando os efeitos da tutela antecipada, e no mérito: seja mantido até quanto necessário e recomendado o tratamento na forma como prescrito na receita e laudo médico. Pleiteou a concessão da AJG e a inversão do ônus da prova. Atribuiu à causa o valor de R$10.810,32. Juntou documentos.

Deferida a tutela provisória postulada, a AJG e a inversão do ônus da prova (evento 8). Interposto agravo de instrumento da decisão, restou desprovido (eventos 24, 29 e 32).

Citada, a ré apresentou contestação (evento 19). Referiu que a pretensão da parte autora não encontra respaldo contratual, regulamentar ou legal, e por isso é manifestamente improcedente. Informou que, conforme se verifica no contrato, a Autora é beneficiária de plano privado de assistência à saúde familiar, portanto, de plano de saúde designado "regulamentado", sujeito às normas da LPS, bem como às normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defendeu que os únicos medicamentos de uso domiciliar de cobertura obrigatória, em relação aos planos de saúde regulamentados, são os medicamentos antineoplásicos, sendo que o medicamento postulado pela parte autora, não se trata daqueles para tratamento de câncer. Argumentou a taxatividade do Rol da ANS. Requereu a total improcedência da ação. Juntou documentos.

Não houve réplica.

Instadas acerca das provas a produzir, requereu a parte autora o julgamento antecipado do feito (evento 41).

Sem mais, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. **DECIDO.**

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que requer a parte autora seja determinada à requerida fornecer o tratamento indicado para a moléstia que lhe acomete Trombofilia (CID 099.1), consistente na medicação Enoxaparina sódica 40mg para aplicação 1x ao dia durante toda a gestação, até 6 semanas após o parto (ev. 1, Laudo 8):

CLÍNICA PULITA
Ginecologia, Obstetrícia e Medicina Reprodutiva

RELATÓRIO MEDICO

A paciente GECICA SAUTHIER PENZ realizou tratamento para engravidar e está gestante de 6,0 semanas. Apresentou nos seus exames, em anexo, alterações imunológicas compatíveis com o diagnóstico de Sindrome Antifofolípide – CID 099.1. Esta patologia, se não tratada adequadamente está envolvida não somente em casos de abortamentos, mas também relacionadas a complicações obstétricas que vão desde a elevação da pressão arterial, diminuição do líquido amniótico, retarde e crescimento fetal intra-utero até mesmo morte fetal intra-útero. Pode ainda levar a trombose venosa, acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio etc.

Desta forma, a paciente acima referida deverá utilizar a medicação VERSA, na dose de 40 mg por dia do início da gestação até 6 semanas após o seu término sob o risco de desenvolver qualquer complicação descrita acima se não utilizá-la. Não deve utilizar medicamento genérico ou similar devido a diferença em biodisponibilidade e bioequivalência.

Dr. Silvio Pulita
Ginecologia e Obstetricia
CRM 20509

Não há controvérsia acerca da contratação do plano de saúde, de ser a autora portadora da doença citada e a necessidade do fornecimento do tratamento indicado.

Discute-se nos autos se faz jus a parte autora ao tratamento prescrito, eis que, conforme a ré, não estaria previsto sua dispensação no contrato, eis que de uso domiciliar.

Ab initio, sinalo que o caso em testilha deve ser apreciado a luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, *in litteris*:

> *Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.*
>
> *§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.*
>
> *§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

Sendo assim, é inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do *pacta sunt servanda*, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente.

Logo, possível é a adequação dos contratos de seguro aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade *pleno iure* das cláusulas que *"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade"* (artigo 6º, inciso V, c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor).

A questão, de outro lado, resta pacificada no egrégio STJ, onde foi editada a Súmula 608, com o seguinte teor: *"Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*

Acrescente-se, ainda, ser um direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores. Nesse sentido, preceitua o artigo 6º, inciso III, do Estatuto Consumerista, *in verbis*:

> "*Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;"*

Consabido que as restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante, mormente em se tratando do contrato que objetiva a prestação de serviços ligados a saúde das pessoas.

Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, nestes termos, é inconcebível que a requerida tenha negado a cobertura ao tratamento medicamentoso, indispensável para o controle da doença que acomete a parte autora, nos termos da Lei n. 9.656/1998, artigo 12, inciso I – Procedimento incorporado às coberturas mínimas, bem assim art. 10, *in verbis*:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**:*
> *I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
> *II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*
> *III - inseminação artificial;*
> *IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*
> *V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento **domiciliar**, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
> *VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;*
> *VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar; (Vide Medida Provisória nº 1.685-5, de 1998) (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
> *IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;*
> *X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.*
> *§ 1º **As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS**. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
> *[...]*
> *§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Vide Medida Provisória nº 1.665, de 1998) (...).*
>
> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...)*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> ***a)** cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;*
>
> ***b)** cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, **solicitados pelo médico assistente;***
>
> ***c)** cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*

Ademais, em que pese o tratamento domiciliar não estar previsto no rol de exigências mínimas estipulado no artigo 12 da Lei nº. 9.656/98 e as cláusulas gerais contenham previsão de exclusão da cobertura, a patologia em si possui cobertura contratual, pelo que, considerando a imprescindibilidade do medicamento, deve prevalecer a cobertura contratual de modo genérico, pena de consideração como abusiva a cláusula ou interpretação restritiva à luz do artigo 54 do Código Consumerista.

Com efeito, incumbe ao médico assistente estabelecer o melhor tratamento a ser prescrito, de acordo com as peculiaridades da patologia de cada paciente, não sendo dado à operadora do plano de saúde negar a cobertura.

No caso em apreço, restou comprovado que o tratamento postulado se mostrava imprescindível para o tratamento da doença que acomete a consumidora, conforme atestado médico e documentos acostados à inicial.

Resta extreme de dúvidas que a doença se afigurava grave e a não realização do tratamento adequado acarreta riscos à saúde da autora.

Em se tratando de negativa de cobertura abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, afigura-se indevida a recusa da operadora.

Ademais, entendo que, depois da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de negar a cobertura ao tratamento indispensável à parte autora.

Existe um dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessários à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, com a ressalva tão-somente das exceções previstas em Lei.

A restrição de cobertura a determinadas enfermidades ou tratamentos é abusiva, por exonerar o prestador de serviços da obrigação de assumir os riscos referentes à necessidade futura de assistência médico hospitalar, dever que é inerente à finalidade do contrato.

Destarte, é dever do demandado em fornecer o tratamento pleiteado.

Sobre a espécie, oportuno citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTO. CLEXANE. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrente e negou o fornecimento do medicamento CLEXANE 40mg, sob o argumento de que tal fármaco não está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar RN nº. 428/2017. O laudo médico colacionado a fl. 25 dos autos do presente agravo de instrumento comprovou que há a urgência e a probabilidade do direito, uma vez que o médico elencou que é imprescindível que a parte recorrente receba o tratamento objeto da demanda. Ademais, em que pese o tratamento domiciliar não estar previsto no rol de exigências mínimas estipulado no artigo 12 da Lei nº. 9.656/98 e as cláusulas gerais contenham previsão de exclusão da cobertura, a patologia em si possui cobertura contratual (TROMBOFILIA), pelo que, considerando a imprescindibilidade do medicamento, deve prevalecer a cobertura contratual de modo genérico, pena de consideração como abusiva a cláusula ou interpretação restritiva à luz do artigo 54 do Código Consumerista. De conseguinte, visto que o fármaco possui registro na ANVISA e se mostra imprescindível para a boa terapêutica da apelante, conforme expressamente elencado no laudo médico (fl. 25), tendo em vista que a exclusão de cobertura se mostra abusiva, pelo que a agravada deve fornecer o medicamento nos precisos termos do laudo prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da beneficiária, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Merece guarida o pedido formulado pela recorrente, pois comprovadamente, foi indicado pelo médico e, ainda, não possui substituto eficaz, razão pela qual não pode ser excluído da cobertura assistencial a ser oferecida pela operadora do plano de saúde, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato entabulado entre as litigantes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 70078096575, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 19/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ.
1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde.
*2. **O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo**.*
3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.
4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
*(AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, **TERCEIRA TURMA**, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) [grifei]*

A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, considera que o local da administração do medicamento é irrelevante para definir o dever de cobertura pelo plano de saúde, na medida em que, havendo cobertura para a doença, como é o caso dos autos, deve ser fornecido o medicamento ministrado pelo médico, mesmo que para uso domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA À COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA ABUSIVIDADE RECONHECIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1791318/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2º E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do NCPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)

Destarte, a procedência da demanda é medida que se impõe, determinando à demandada que custeie o medicamento Enoxaparina sódica 40mg para aplicação 1x ao dia durante toda a gestação, até 6 semanas após o parto (Evento 1, Laudo 8), ou conforme indicação médica, mediante a apresentação da prescrição médica.

Dispositivo.

Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido formulado por **GECICA SAUTHIER PENZ** em face de **Unimed - Cooperativa de Serviços de Saúde Vales Taquari e Rio Pardo Ltda.** para confirmar a antecipação de tutela deferida (evento 8), que determinava à requerida que custeasse o medicamento Enoxaparina sódica 40mg para aplicação 1x ao dia, até 06 semanas após o parto, ou conforme indicação médica.

Considerando a sucumbência, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista o trabalho do profissional, o tempo de duração da demanda e ausência de dilação probatória.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com baixa.

Interposta a Apelação pela parte autora/requerida, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo de 15 dias.

Com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO GILBERTO MARRONI VITOLA, Juiz de Direito**, em 13/4/2022, às 15:55:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10017681273v4** e o código CRC **df007379**.